LAUDO DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

Paciente

Nome: CARLOS ALBERTO RAMOS GOMES
Nascimento: 18/07/1958 (68 anos) | **Sexo:** Masculino | **Documento:** CPF 111.444.777-35
Contato: (31) 99999-9999

Paciente colaborativo, acompanhado pela esposa. Mora em sobrado e sobe as escadas sem parar para descansar.

Solicitação

Médico solicitante: DR. JORGE HENRIQUE MEIRELES (CIRURGIA GERAL)
Procedimento proposto: COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (Eletiva)

Colelitíase sintomática, com três episódios de cólica biliar nos últimos seis meses. Cirurgia programada, duração estimada de 60 a 90 minutos, sob anestesia geral.

Avaliação realizada por

Dr. ROBERTO MARINHO (CARDIOLOGISTA) - CRM/MG 12345

Exame físico

Paciente apresenta IMC 28.4 (Altura 1.72 m, Peso 84 kg), SC 2.00 m2, PA 138 x 84 mmHg, FC 72 bpm, FR 16 irpm, SatO2 96%.

Estado geral: bom, hidratado, afebril, consciente e orientado.

Cardiovascular: bulhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros ou terceira bulha. Sem estase jugular. Pulsos periféricos simétricos.

Respiratório: murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios.

Abdome: flácido, dor leve à palpação profunda em hipocôndrio direito, sem massas ou sinais de irritação peritoneal.

Extremidades: sem edema, sem sinais de trombose venosa.

Medicamentos e alergias

Medicamentos em uso: Losartana 50 mg de 12 em 12 horas; Metformina 850 mg de 12 em 12 horas; Atorvastatina 40 mg à noite; AAS 100 mg ao dia; Bisoprolol 5 mg ao dia

Penicilina (erupção cutânea). Nega alergia a látex ou a contraste.

Exames complementares

Glicemia de jejum: 118 mg/dL
Ureia: 38 mg/dL
Creatinina: 1.1 mg/dL
Sódio: 139 mEq/L

Potássio: 4.3 mEq/L
Hemoglobina: 13.8 g/dL
Hematócrito: 41.5 %
Leucócitos: 7200 /mm3
Plaquetas: 245000 /mm3
TP (tempo de protrombina): 12.5 seg
INR: 1.05
TTPa: 30 seg
Grupo sanguíneo e fator Rh: O+
AST (TGO): 28 U/L
ALT (TGP): 31 U/L
Bilirrubina total: 0.9 mg/dL
Colesterol total: 188 mg/dL
HDL: 46 mg/dL
LDL: 112 mg/dL
Triglicerídeos: 150 mg/dL
HbA1c: 6.8 %
TSH: 2.1 uUI/mL
Eletrocardiograma (ECG): Ritmo sinusal, 72 bpm. Onda Q em DII, DIII e aVF (infarto inferior antigo). Sem alterações agudas de ST-T.
Ecocardiograma - FE: 55 %
Ecocardiograma - Resultado/Laudo: Ventrículo esquerdo de dimensões normais, com hipocinesia inferior leve. Função sistólica preservada. Sem valvopatias significativas.
Teste ergométrico: Teste ergométrico (há 4 meses): negativo para isquemia até 8 METs.
Radiografia de tórax: Área cardíaca normal. Campos pulmonares sem infiltrados.

Ultrassonografia de abdome: vesícula com múltiplos cálculos, parede de 3 mm, vias biliares de calibre normal.

Risco trombótico e de sangramento

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

EMAPO: Baixo - 5 pontos (<3%)
ASA: ASA/PS 3 (1.8%-4.4%)
ACP: Risco intermediário - 5 pontos (3%-15%)
Lee (RCRI): Classe II - 1 pontos (0.9%)
NSQIP-MICA (Gupta): Incompleto (Responda a classe ASA e o tipo de cirurgia para calcular o risco.)

CONCLUSÃO

Paciente de 68 anos, com hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e doença coronariana estável, em boa classe funcional e compensado clinicamente. **Liberado para a cirurgia proposta**, com risco cardiovascular intermediário.

Recomendações:

- Manter o betabloqueador e a estatina, inclusive no dia da cirurgia.
- Suspender a metformina 24 horas antes; controle de glicemia capilar no perioperatório.
- Manter o AAS, salvo orientação contrária do cirurgião.
- Profilaxia de tromboembolismo venoso conforme protocolo institucional.
- Monitorização eletrocardiográfica contínua durante o procedimento.

As escalas de risco devem ser utilizadas como ferramentas de apoio à decisão clínica e não substituem a avaliação, o julgamento clínico nem a experiência do médico responsável pelo paciente, que são determinantes na conduta final.